

Acadêmico (a): _____

ENAMED

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES:

1. *Esta prova possui questões objetivas de conhecimento específico.*
2. *Todas as respostas devem ser de caneta azul ou preta.*
3. *Não é permitido o uso de celulares e outros objetos eletrônicos.*
4. *Esta prova é individual. São vedados: qualquer comunicação entre os presentes.*
5. *Não é permitido durante a prova a solicitação de dúvidas ao professor.*

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Questão 01

Segundo a Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html#CAPITULOI

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. Nem todos os pontos de atenção à saúde são importantes para que os objetivos da rede de atenção à saúde sejam cumpridos.
- II. Os pontos de atenção à saúde são espaços em que se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular.
- III. Um dos objetivos da RAS é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

Questão 02

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em relação à infraestrutura e à ambiência, deve

- I. estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especificidades.
- II. considerar a densidade demográfica, perfil da população e as ações e serviços de saúde a serem realizados.
- III. ter pontos de apoio para o atendimento de populações dispersas (rurais, ribeirinhas, assentamentos etc.).

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 03

Segundo a Portaria nº 198/2004, que institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, a condução local/regional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde será efetivada mediante um Colegiado de Gestão configurado como polo de educação permanente em saúde para o SUS com as funções de

- I. identificar necessidades de formação e de desenvolvimento dos trabalhadores de saúde e construir estratégias e processos que qualifiquem a atenção e a gestão em saúde e fortaleçam o controle social no setor na perspectiva de produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- II. mobilizar a formação de gestores de sistemas, ações e serviços para a integração da rede de atenção como cadeia de cuidados progressivos à saúde (rede única de atenção intercomplementar e de acesso ao conjunto das necessidades de saúde individuais e coletivas);
- III. articular e estimular a transformação das práticas de saúde e de educação na saúde no conjunto do SUS e das instituições de ensino, tendo em vista a implementação das diretrizes curriculares nacionais para o conjunto dos cursos da área da saúde e a transformação de toda a rede de serviços e de gestão em rede-escola.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 04

Assinale a opção que indica o *princípio* da Política Nacional de Humanização que visa ao aumento do grau de comunicação intra e intergrupos e à transformação dos modos de relação e de comunicação entre os sujeitos implicados nos processos de produção de saúde.

- A) Pluralidade.
- B) Diversidade.

- C) Verticalidade.
- D) Transversalidade.
- E) Heterogeneidade.

Questão 05

Assinale a opção que, segundo a Resolução nº 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), apresenta a definição de *vigilância em saúde*.

- A) Processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de Saúde Pública.
- B) Ações que propiciam o conhecimento e a investigação diagnóstica de doenças e agravos e a verificação da qualidade de produtos de interesse de saúde pública e do padrão de conformidade de amostras ambientais.
- C) Promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde, articuladas com as demais redes de proteção social, abrangendo atividades voltadas para adoção de práticas sociais e de saúde centradas na equidade, na participação e no controle social.
- D) Ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do País, Estado, Região, Município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde.
- E) Conjunto articulado de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

Questão 06

A Portaria nº 837/2014 estabelece que a Equipe de Saúde da População Ribeirinha (eSFR) será composta por, no mínimo,

- A) dois médicos, preferencialmente da especialidade de Família e Comunidade; um enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família; um microscopista; e dois agentes de saúde.
- B) um médico, preferencialmente da especialidade de Família e Comunidade; um enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família; e um auxiliar ou técnico de enfermagem.
- C) um médico, preferencialmente da especialidade de Família e Comunidade; um enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família; um cirurgião dentista, especialista em Saúde da Família; e um auxiliar ou técnico de enfermagem.
- D) um médico, preferencialmente da especialidade de Família e Comunidade; um enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família; um cirurgião dentista, especialista em Saúde da Família; e quatro agentes de saúde.
- E) um médico, preferencialmente da especialidade de Família e Comunidade; um enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família; um cirurgião dentista, especialista em Saúde da Família; um técnico ou auxiliar em saúde bucal; e dois auxiliares ou técnicos de enfermagem.

Questão 07

A estratégia Consultório na Rua foi instituída pela Política Nacional de Atenção Básica, em 2011, e visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde. Todas as ações realizadas pelas equipes de Consultório na Rua (eCR) devem ser registradas na(o)

- A) Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
- B) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

- C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
- D) Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (Sisab).
- E) Sistema de Dados de Populações Vulneráveis (SDPV).

Questão 08

Segundo o Art. 3º, inciso IV, da RDC nº 36/2013, assinale a opção que apresenta o conceito de *evento adverso*.

- A) O comprometimento da estrutura ou da função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo.
- B) O efeito que surge por meio de alguma reação distinta daquela que produz o efeito terapêutico.
- C) O efeito causado por fármaco que leva ou pode levar a um desfecho negativo.
- D) A ocorrência imprevista que acontece durante a assistência à saúde.
- E) O evento ou circunstância que resulte em dano à saúde.

Questão 09

Sobre a qualidade de um estudo epidemiológico, assinale a afirmativa correta.

- A) Não está relacionada à representatividade dos participantes.
- B) Não requer pré-teste de instrumentos desenvolvidos pelo estudo.
- C) Se as variáveis de confusão estão previstas podem ser ou não controladas.
- D) Depende fundamentalmente da definição prévia do tamanho da amostra.
- E) Depende da adequada definição da população de estudo e do método de seleção dos participantes.

Questão 10

A distribuição da proporção de óbitos por causas mal definidas entre idosos e a taxa de pobreza (proporção da população com renda per capita inferior a meio salário-mínimo), segundo a macrorregião brasileira. Sabe-se que, para o conjunto da população idosa brasileira, cerca de 65% dos óbitos sem causa básica conhecida ocorrem sem assistência médica. Assim, a maior proporção de mortes por causas mal definidas nas regiões com maior proporção de habitantes com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo sugere que a falta da assistência médica ao idoso está associada à pobreza. Lima-Costa et al. (2000).

A partir do trecho acima, assinale a afirmativa correta.

- A) A ocorrência de óbitos sem causa básica conhecida para o conjunto da população idosa brasileira não mostra relação com a assistência médica.
- B) A falta de assistência médica está associada ao nível socioeconômico da população idosa.
- C) Os idosos que morreram sem assistência necessariamente eram os de menor renda.
- D) A morte por causas mal definidas não está associada à renda familiar *per capita*.
- E) Foi observada maior proporção de mortes por causas mal definidas nas regiões com menor proporção de habitantes com renda familiar per capita inferior a meio salário-mínimo.

Questão 11

Um estudo desenvolvido para determinar a prevalência e os fatores sociodemográficos associados à depressão mostrou que, em uma amostra representativa da população da cidade com mais de 18 anos de idade (1.041 participantes), os episódios depressivos apresentavam maior prevalência no sexo feminino, maior prevalência nos mais velhos e maior prevalência entre aqueles que não estavam trabalhando. As determinações do episódio depressivo e da ocupação foram feitas simultaneamente.

Vorcaro *et al*, (2001).

Nesse caso, estamos diante de um estudo

- A) ecológico.
- B) caso-controle.
- C) seccional.
- D) coorte retrospectivo.
- E) coorte misto.

Questão 12

A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Sobre essa lei, assinale a afirmativa correta.

- A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Legislativo ou pelo Conselho de Saúde.
- C) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, formula as estratégias mas não controla a execução da política de saúde na instância correspondente.
- D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), terão uma única representação no Conselho Nacional de Saúde.
- E) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, definidas pelo governo Federal.

Questão 13

A Política Nacional de Humanização mostra a humanização como política pública que transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS e, em razão disso,

- A) traduz os modos de operar dos diferentes equipamentos, mas não dos sujeitos da rede de saúde.
- B) orienta as práticas de atenção e gestão, a partir da experiência exclusiva do usuário.
- C) realiza trocas solidárias e comprometidas com a tarefa única de produção de saúde.
- D) oferece um eixo articulador das práticas em saúde, destacando somente o aspecto objetivo.
- E) inclui gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

Questão 14

Sobre a Resolução (RDC) nº 36/2013, que instituiu ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, assinale a afirmativa correta.

- A) É aplicável somente aos serviços públicos de saúde.
- B) É aplicável exclusivamente aos serviços de saúde, sejam eles públicos, filantrópicos, civis ou militares.
- C) É aplicável apenas aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares.

D) É aplicável aos serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, incluindo os consultórios individualizados.

E) É aplicável aos consultórios individualizados, aos laboratórios clínicos e aos serviços móveis e de atenção domiciliar.

Questão 15

Sobre o Decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, assinale a afirmativa correta.

A) *Comissões Intergestores* são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para avaliação de desempenho do SUS.

B) *Mapa da Saúde* consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados exclusivamente pelo SUS.

C) *Rede de Atenção à Saúde* se refere ao conjunto de ações e serviços de saúde articulados em nível primário.

D) *Serviços Especiais de Acesso Aberto* são os serviços específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento de urgência.

E) *Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica* é o documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença, o tratamento preconizado, os mecanismos de controle clínico e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Questão 16

Sobre *Rede de Atenção à Saúde*, assinale a afirmativa correta.

A) São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, com densidade tecnológica básica, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

B) Promove a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementa o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica.

C) Caracteriza-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS).

D) Caracteriza-se pela não centralidade nas necessidades em saúde de uma população, mas pela responsabilização na atenção contínua e integral.

E) Caracteriza-se pelo cuidado multiprofissional sem o compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos.

Questão 17

Sobre a *Atenção Primária em Saúde*, assinale a afirmativa correta.

A) Configura-se como o nível de atenção de média complexidade.

B) Enfatiza a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde, a partir do qual se realiza e coordena o cuidado nos pontos de atenção básica.

C) Entende os pontos de atenção à saúde como espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular.

D) Afirma que as unidades básicas de saúde e as unidades ambulatoriais especializadas são, exclusivamente, pontos de atenção à saúde.

E) Determina que os hospitais não podem abrigar distintos pontos de atenção à saúde.

Questão 18

Assinale a opção que apresenta Princípios do SUS e da RAS que devem ser operacionalizados na Atenção Básica.

- A) Universalidade, equidade, integralidade e longitudinalidade do cuidado.
- B) Universalidade, equidade, coordenação do cuidado e integralidade.
- C) Universalidade, ordenação da rede, equidade e integralidade.
- D) Universalidade, equidade, regionalização, hierarquização e integralidade.
- E) Universalidade, equidade e integralidade.

Questão 19

A Portaria GM/MS nº 635/2023, Institui, define e cria incentivo financeiro federal de implantação, custeio e desempenho para as modalidades de equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde.

Assinale a opção que apresenta ações do processo de trabalho das eMulti.

- A) O atendimento individual e em grupo; as atividades coletivas; o apoio matricial e as discussões de casos; mas não o atendimento domiciliar.
- B) O atendimento individual e em grupo; as atividades coletivas; a oferta de ações de saúde à distância; o apoio matricial e as discussões de casos; mas não o atendimento domiciliar.
- C) O atendimento individual e em grupo; as atividades coletivas; a oferta de ações de saúde à distância; o apoio matricial e as discussões de casos; mas não o atendimento domiciliar.
- D) O atendimento individual e em grupo; as atividades coletivas; a oferta de ações de saúde à distância; o apoio matricial e as discussões de casos, a construção conjunta de projetos terapêuticos e intervenções no território; mas não o atendimento domiciliar.
- E) O atendimento individual e em grupo; as atividades coletivas; a oferta de ações de saúde à distância; o apoio matricial e as discussões de casos; e as práticas intersetoriais.

Questão 20

Sobre os valores e os princípios da Política Nacional de Promoção à Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O reconhecimento da subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.
- II. A consideração da solidariedade, da felicidade e da ética, o respeito às diversidades, à humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua concretização.
- III. A consideração da humanização, da corresponsabilidade, da justiça e da inclusão social como valores fundantes no processo de sua concretização.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 21

Alice, 30 anos, chega à unidade básica de saúde com tosse seca, chiado no peito e dispneia aos grandes esforços, com piora à noite. Não tem história de febre, não apresenta perda de peso e a mucosa nasal está sem alterações. Piora com a fumaça de cigarro do marido. Ao exame pulmonar, apresenta tosse, murmúrio vesicular e sibilos difusos, especialmente na expiração forçada. Não apresenta outras alterações. Pesa 60 kg, tem 1,60 m de altura, seu IMC é 21,5 kg/m², a FC está em 77 bpm e a FR, em 15 irpm. O exame cardiovascular indica ritmo regular em 2 tempos, sem sopro e sem alteração de ictus. O abdômen está normotenso, depressível, sem organomegalias ou ruídos hidroaéreos presentes.

O diagnóstico provável é:

- A) asma;
- B) rinosinusite;
- C) DPOC;
- D) tuberculose;
- E) pneumonia adquirida na comunidade.

Questão 22

Carlos, 27 anos, vai à consulta médica com febre, exantema, gânglios retroauriculares aumentados, conjuntivite, artralgia e tosse. Em seu prontuário, não há registro de vacinação contra a rubéola. Ele declara não ter viajado recentemente, nem ter tido contato com pessoas confirmadas para rubéola. Contudo, sua região encontra-se no estado que registrou um surto da doença há 4 meses. Trata-se de um caso suspeito de rubéola.

O melhor método para fazer a confirmação desse caso é:

- A) examinar se há vínculo epidemiológico com outros casos confirmados;
- B) realizar a sorologia de anticorpos IgM e IgG contra rubéola;
- C) verificar a associação temporal com a vacinação;
- D) considerar os critérios clínicos como suficientes, diante dos sinais e sintomas presentes;
- E) observar o caso por 48 horas.

Questão 23

Letícia está na 10^a semana de gestação. Diante do aumento de casos de gripe entre familiares e conhecidos, ela foi à unidade básica de saúde para saber se precisava tomar a vacina contra influenza. Na análise em seu prontuário, verificou-se que sua última vacina havia sido no ano anterior.

Em relação a esse caso, é correto afirmar que:

- A) não se recomenda a vacina nesse estágio da gestação;
- B) não é necessário o reforço da vacina, pois ela confere imunidade por 10 anos;
- C) deve-se evitar a vacina na gestação;
- D) a paciente deve ser revacinada;
- E) a vacina deve ser tomada, por segurança, após 12 semanas de gestação.

Questão 24

Em uma atenção primária de qualidade, é papel da APS integrar verticalmente os serviços. A APS, como parte integrante da rede de atenção à saúde, estrutura-se segundo atributos e funções. Além da

resolubilidade, são funções da APS:

- A) organização e responsabilização;
- B) organização e primeiro contato;
- C) primeiro contato e longitudinalidade;
- D) integralidade e coordenação;
- E) coordenação e orientação comunitária.

Questão 25

Milton teve o diagnóstico de *monkeypox* confirmado por meio de PCR positivo. Ele se enquadra no grupo de indivíduos com alto risco de desenvolver formas graves. Seu monitoramento deve acontecer:

- A) a cada 2 dias;
- B) a cada 3 dias;
- C) a cada 7 dias;
- D) a cada 15 dias;
- E) diariamente.

Questão 26

Geraldo, 37 anos, adscrito à unidade básica de saúde, chega para consulta apresentando sintomas psicóticos. Como parte de seu delírio persecutório, recusa-se a ser medicado e não aceita ser encaminhado para o CAPS.

Nesse caso, a conduta correta é:

- A) encaminhar para o CAPS mesmo assim, pois a unidade não tem recurso para esse atendimento;
- B) insistir com a medicação, que é condição para um plano terapêutico adequado;
- C) fazer o acolhimento de Geraldo e convencê-lo a aderir ao tratamento para os problemas identificados;
- D) fazer o acolhimento de Geraldo, avaliar o quadro clínico geral e pactuar o acompanhamento na medida de suas limitações, lançando mão da entrevista motivacional se possível;
- E) chamar a ambulância para levá-lo compulsoriamente para a internação.

Questão 27

Apolinário, 86 anos, perfil 3 de funcionalidade, com Alzheimer em estágio avançado, hipertenso, diabético e com imobilidade grau IV, em uso de medicação para as doenças de base, é levado à consulta médica.

Sobre seu quadro clínico, é correto afirmar que:

- A) deve ser feito controle rigoroso da hipertensão e diabetes, com vistas à reabilitação;
- B) todas as medicações em uso certamente são essenciais e devem ser mantidas, independentemente de se configurar a polifarmácia;
- C) Apolinário apresenta dependência parcial para as atividades básicas da vida diária;
- D) uma equipe multiprofissional deve ser acionada para reabilitação de Apolinário;
- E) Apolinário é um paciente em cuidados paliativos prolongados ou em fase final de vida.

Questão 28

Mylena, 42 anos, fuma 50 cigarros/dia desde os 16 anos. Seu Fagerström é igual a 10. Na escala de razões para fumar, declara que fuma para controlar o peso, para mediar situações de estresse e ansiedade e porque o cigarro é uma companhia. Diz que não consegue nem imaginar tentar parar de fumar e que, por isso, nunca tentou fazê-lo. Declara não se ver sem o cigarro. Recentemente, Mylena foi diagnosticada com neoplasia de pulmão.

Nesse caso, a abordagem a essa fumante deve considerar:

- A) uso de vapers para iniciar o processo de mudança;
- B) cessação do tabagismo sem uso de suporte farmacoterápico;
- C) cessação do tabagismo com uso de reposição de nicotina apenas;
- D) entrevista motivacional, com o suporte comportamental e farmacoterápico necessário;
- E) prescrição de bupropiona para cessação do tabagismo.

Questão 29

Rodrigo, 48 anos, casado, autônomo, vem à unidade básica de saúde se queixando de dores de cabeça de repetição e apresentando PA = 165 x 90 mmHg. Em seu prontuário, identifica-se que, nas últimas 5 consultas, no último ano, por motivos diversos, sua pressão arterial foi, respectivamente, de 147 x 99 mmHg; 180 x 100 mmHg; 152 x 90 mmHg; 160 x 95 mmHg e 170 x 92 mmHg. Rodrigo tem história familiar de hipertensão e é sedentário. O fato que permite o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica é:

- A) ter sido admitido em unidade de pronto atendimento com pressão arterial 150 x 95 mmHg;
- B) ser sedentário;
- C) ter tido história familiar de hipertensão;
- D) ter tido aferições da pressão arterial maiores que 140 x 90 mmHg no último ano;
- E) ter 48 anos de idade.

Questão 30

Foram atendidas 5 irmãs na unidade básica de saúde. A única que tem características que permitem o diagnóstico de diabetes mellitus é:

- A) Maria Hilma, de 49 anos, que realizou teste de glicemia capilar com resultado 179 mg/dl;
- B) Maria José, que, em 01/03/2024, apresentou hemoglobina glicada (HbA1c) = 5,6% e, em 12/07/2024, apresentou hemoglobina glicada (HbA1c) = 6,1%;
- C) Maria Lina, que apresentou, em 01/03/2024, glicemia de jejum = 136 mg/dl e, em 12/07/2024, glicemia de jejum = 152 mg/dl;
- D) Maria Cláudia, que apresenta glicemia de jejum = 126 mg/dl;
- E) Maria Antônia, que apresenta hemoglobina glicada (HbA1c) = 4,5%.

Questão 31

José, 55 anos, hipertenso há 3 anos, em uso regular de medicação, vem para consulta de rotina apresentando PA = 130 x 80 mmHg. Após exame clínico, conclui-se que tem baixo risco cardiovascular.

Nesse caso, a conduta é:

- A) manter a medicação e reforçar a importância de manter a mudança de estilo de vida, pois a PA está dentro da meta;

- B)** retirar a medicação e reforçar a importância de manter a mudança de estilo de vida, pois a PA está dentro da meta;
- C)** modificar a medicação para que o organismo não crie tolerância às medicações atuais, embora a PA esteja dentro da meta;
- D)** reforçar a mudança de estilo de vida, pois a PA está fora da meta;
- E)** modificar a conduta medicamentosa, pois a PA está fora da meta.

Questão 32

Leonora, 60 anos, com diabetes mellitus diagnosticada há 5 anos, em acompanhamento contínuo na unidade básica de saúde, vem para a consulta de rotina. Após avaliação dos pés, identificamos: sensibilidade presente, deformidade ausente e úlceras ou cicatrizes de úlceras ausentes. Segundo o exame clínico do pé diabético, conclui-se que a categoria de risco e o melhor manejo para Leonora são, respectivamente:

- A)** grau 0 – reavaliação anual;
- B)** grau I – reavaliação anual;
- C)** grau II – reavaliação semestral;
- D)** grau III – reavaliação semestral;
- E)** grau IIIa – reavaliação semestral.

Questão 33

Vanda, 92 anos, hipertensa, com diagnóstico de Alzheimer há 16 anos, acamada, estável, sem lesões por pressão, sem histórico recente de internação, tem uma filha, Joana, de 68 anos, que faz o manejo diário: banho no leito, administração de medicação, dieta enteral, mudança de decúbito. A filha está bem orientada e procura se informar sobre o quadro e as melhores condutas. Nesse caso, o plano terapêutico singular deve:

- A)** dar suporte à cuidadora, acompanhá-la regularmente para avaliação de sobrecarga no cuidado e manter o acompanhamento de Vanda pela equipe da APS;
- B)** agendar consultas regulares de fisioterapia e fonoaudiologia e encaminhamento ao geriatra para acompanhamento da doença de Alzheimer;
- C)** agendar consultas regulares de nutricionista e encaminhamento ao CER para reabilitação da deglutição;
- D)** dar suporte à cuidadora e encaminhar Vanda para o serviço de atenção secundária domiciliar para reabilitação da deglutição por fonoaudióloga;
- E)** fornecer acompanhamento regular com fonoaudióloga e nutricionista e encaminhar a paciente ao serviço de cuidados paliativos.

Questão 34

Com queixa de dor de cabeça, Jéssica, 37 anos, diarista, vai pela primeira vez à unidade básica de saúde. Ela reporta: “Doutor, sinto essa dor há mais de 2 meses, desde que precisamos sair da nossa casa porque não dava mais para pagar o aluguel depois que meu marido foi demitido do emprego. Na minha casa somos eu, meu marido e três filhas de 4, 6 e 14 anos”. É exemplo de crise acidental do ciclo de vida familiar da família de Jéssica:

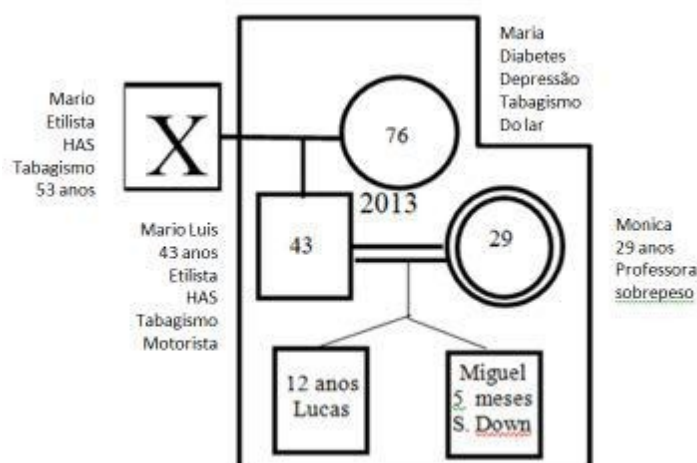
- A)** família com filho pequeno;
- B)** família em estágio tardio;
- C)** desemprego;
- D)** família com criança em idade escolar;

E) família com adolescente.

Questão 35

Mônica, 29 anos, professora, vem para a consulta na unidade básica de saúde preocupada com seu sobrepeso. Diz que anda muito estressada, que os cuidados com o filho mais novo têm tomado muito seu tempo e que o marido não ajuda e anda bebendo demais. Sua sogra Maria foi morar com eles e dá muito trabalho em virtude do quadro depressivo, que não melhora. O sogro, Mário, faleceu aos 53 anos, e isso a preocupa em relação a Mário Luís, seu marido, que também fuma e bebe demais. Eles têm ainda um filho de 12 anos, que não dá trabalho nenhum.

Considere o genograma a seguir.



O genograma de Mônica mostra que:

- A) existe um padrão repetitivo de comportamento e saúde entre Mário e Mário Luís;
- B) existe uma relação conflituosa entre Mônica e Maria;
- C) existe uma relação conflituosa entre Mônica e Mário Luís;
- D) Maria e Mário são divorciados;
- E) Mário Luís é o indivíduo índice do genograma.

Questão 36

Tatiana vem à consulta médica com queixa de dor lombar. Em sua consulta anterior, apresentou pressão arterial de 120 x 65 mmHg, FC normal, peso 59 kg, altura 1,60 m e FR normal. Ela declara ter alergia a dipirona. De acordo com seu prontuário, seu último Papanicolau foi há 3 anos. Tatiana relata se sentir sem energia e ter medo de essas dores serem alguma doença ruim. Diz que não tem conseguido mais dormir de preocupação. Em relação ao registro das informações fornecidas por Tatiana no Registro Clínico Orientado por Problemas (RCOP), é correto afirmar que:

- A) devem ser registradas no campo Subjetivo as informações “apresentou pressão arterial 120 x 65 mmHg, FC normal, peso 59 kg, altura 1,60 m e FR normal”;
- B) devem ser registradas no campo Objetivo as informações “apresentou pressão arterial 120 x 65 mmHg, FC normal, peso 59 kg, altura 1,60 m e FR normal”;
- C) devem ser registradas no campo Avaliação as informações “apresentou pressão arterial 120 x 65 mmHg, FC normal, peso 59 kg, altura 1,60 m e FR normal”;
- D) devem ser registradas no campo Avaliação as informações “Tatiana relata se sentir sem energia e ter medo de essas dores serem alguma doença ruim. Diz que não tem conseguido mais dormir de preocupação”;

E) as informações “Tatiana relata se sentir sem energia e ter medo de essas dores serem alguma doença ruim. Diz que não tem conseguido mais dormir de preocupação” não são relevantes; logo, não devem ser registradas no RCOP.

Questão 37

Um senhor de 82 anos comparece à consulta queixando-se de uma cefaleia de início recente. HAS controlada com IECA. Exame físico sem particularidades, exceto por espessamento da artéria temporal à palpação. Nesse contexto:

- A) PCR elevada aumenta a chance de arterite de células gigantes;
- B) VHS > 100 mm/h aumenta a chance de arterite de células gigantes;
- C) tomografia craniana é essencial para excluir diagnósticos outros, antes de se pensar em arterite de células gigantes;
- D) radiografia craniana é essencial para excluir diagnósticos outros, antes de se pensar em arterite de células gigantes;
- E) ressonância magnética craniana é essencial para excluir outros diagnósticos, antes de se pensar em arterite de células gigantes.

Questão 38

Segundo o Manual de Recomendações e Controle da Tuberculose no Brasil 2ª ed., atualizado em 29/05/2024, a transmissão e adoecimento por TB são influenciados por fatores demográficos, sociais e econômicos. Dentre os fatores que contribuem para a manutenção e propagação da doença, destacam-se: urbanização crescente e desordenada, desigualdade na distribuição de renda, moradias precárias e superlotação, insegurança alimentar e baixa escolaridade, bem como dificuldade de acesso aos serviços e bens públicos. Dessa maneira, no Brasil, assim como em outros países que têm condições de vida semelhantes, alguns grupos populacionais apresentam maior vulnerabilidade para a TB. Pelo exposto acima, em comparação com a população em geral, o risco de adoecimento por tuberculose é maior no seguinte grupo:

- A) indígenas;
- B) profissionais de saúde;
- C) pessoas vivendo com o HIV;
- D) pessoas privadas de liberdade;
- E) pessoas vivendo em situação de rua.

Questão 39

De acordo com parâmetros do Ministério da Saúde, a definição utilizada na vigilância da influenza e da covid-19 para determinar casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é:

- A) indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e com início dos sintomas nos últimos sete dias;
- B) indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos;
- C) em crianças, além da febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos, também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico;
- D) em idosos, critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência;

E) indivíduo com síndrome gripal que apresenta dispneia/desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou saturação de O₂ ≤94% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.

Questão 40

Os movimentos antivacina, causados por um sistema de desinformação, trazem muitos danos para as pessoas não vacinadas, pois já está mais que provado pela ciência que vacinas são muito efetivas e salvam vidas. Uma dessas doenças preveníveis por vacinas tem como manifestação clínica típica a presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas, aderentes, que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas. Essas placas podem se localizar na faringe, na laringe e nas fossas nasais; e, com menos frequência, também são observadas na conjuntiva, na pele, no conduto auditivo, na vulva, no pênis (pós circuncisão) e no cordão umbilical. A doença manifesta-se clinicamente por comprometimento do estado geral do paciente, que pode se apresentar prostrado e pálido. A dor de garganta é discreta, independentemente da localização ou da quantidade de placas existentes, e a febre normalmente não é muito elevada, variando de 37,5 °C a 38,5 °C, embora temperaturas mais altas não afastem o diagnóstico. Nos casos mais graves, há intenso edema do pescoço, com grande aumento dos gânglios linfáticos dessa área (pescoço taurino) e edema periganglionar nas cadeias cervicais e submandibulares. Dependendo do tamanho e da localização da placa pseudomembranosa, pode ocorrer asfixia mecânica aguda no paciente, o que muitas vezes exige imediata traqueostomia para evitar a morte.

A descrição acima é característica de:

- A) vírus sincicial respiratório;
- B) difteria;
- C) faringo-amigdalite por estreptococo;
- D) sífilis;
- E) sarampo.

Acadêmico (a): _____

Fase: _____

Gabarito

Questão 01	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 02	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 03	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 04	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 05	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 06	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 07	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 08	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 09	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 10	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 11	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 12	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 13	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 14	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 15	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 16	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 17	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 18	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 19	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 20	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Questão 21	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 22	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 23	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 24	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 25	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 26	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 27	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 28	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 29	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 30	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 31	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 32	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 33	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 34	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 35	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 36	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 37	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 38	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 39	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Questão 40	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E